

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	新生兒壞死性腸炎 Neonatal Necrotizing Enterocolitis; NEC				
編號	A31000-Q03-W-N03	制定者	NI 邱曉彤	公布日期	97 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 3.8 版/7 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解新生兒壞死性腸炎的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部新生兒科單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

新生兒壞死性腸炎是新生兒尤其是早產兒最常見的腸胃道急症，主要見於體重少於 2000 公克者，常發生於早產兒初期合併症趨於穩定時，特徵是具有敗血症的症狀加上種種胃腸道症候，程度可從輕微腹脹、膽汁性嘔吐、便血甚至嚴重道腸穿孔、腹膜炎、休克等，最常侵犯迴腸與結腸，是極低出生體重早產兒發病率和死亡率的重要原因。

（二）危險因素：周產期窒息或缺氧，早產。

（三）症狀

1. 主要症狀包括腹脹、胃液瀦留、腹瀉、血便、休克；一般症狀包括：嗜睡、呼吸停止、嘔吐（含膽汁）、尿量減少及體溫不穩。

2. 臨床表徵：

(1) 第一階段：懷疑有壞死性腸炎。進食不佳、腸蠕動減少、消化吸收差、胃內殘餘量增加，腹部 X 光顯現腸壁變厚，腸脹氣及腸阻塞。

主題名稱	新生兒壞死性腸炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N03	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	2/7

(2)第二階段：輕中度壞死性腸炎，腹脹（影響橫膈膜的移動且出現呼吸窘迫），腸蠕動聲音消失，血小板數目降低，低血鈉。

(3)第三階段：嚴重壞死性腸炎，腹部 X 光出現腹水，腸壁表面變深或變硬，低血壓，休克，呼吸衰竭。

（四）常見檢查

1.腹部 X 光檢查。

2.糞便常規檢查：Stool OB，Stool Culture。

3.抽血檢查：Blood Culture，CBC/DC，Na，K，Ca，Cl，Albumin、CPR。

（五）常見治療

1.內科治療

(1)禁食，懷疑有壞死性腸炎需立即禁食。

(2)經由鼻胃管減壓、排氣，減輕腹脹及觀察引流物。

(3)靜脈輸液代替經口餵食以減少腸子對於氧氣及血液循環的需求。

(4)給予廣效抗生素 10-14 天。

(5)攝食乳酸桿菌，以使其有良好菌落生長。

(6)若有臍導管需立即拔除。

(7)監測心跳、血壓、呼吸、尿量、皮膚灌流、注意水分補充，維持電解質平衡。

2.外科治療

(1)手術治療時機：病情未改善且逐漸惡化、出現腸穿孔的徵兆時。

(2)部分腸道切除及吻合術或造瘻口術：將壞死的腸子完全切除，再於腹壁上做人
工造口(Ostomy)。

(3)人工造口關閉時機：由醫師評估，並於關閉人工造口同時接回腸子，常於術後
的四到六個月才執行。

（六）護理問題

1.缺乏營養／因疾病。

2.易感染／鼻胃管留置。

主題名稱	新生兒壞死性腸炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N03	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	3/7

（七）護理措施

1. 缺乏營養／因疾病

- (1) 每日以同一磅秤測量新生兒體重。
- (2) 監測實驗室檢查數據（Hb、Albumin 等），並依醫囑補充輸液。
- (3) 觀察新生兒活力改變，密切監測生命徵象。
- (4) 與醫師討論餵食時間和奶濃度。
- (5) 鼓勵病童母親餵母乳並教導母乳收集與保存方法。
- (6) 開始餵食時採漸進式，先給予稀釋的奶品。
- (7) 濃度慢慢增加，在 2-3 週期間才恢復一般奶濃度。
- (8) 於母乳中加入母乳添加劑（一包母乳添加劑可提供 4kcal 及多種維生素與礦物質）。
- (9) 餵食後抬高床頭 30 度，並採右側臥以幫助消化。
- (10) 集中護理減少能量消耗以促進其生長。

2. 易感染／鼻胃管留置

- (1) 接觸新生兒前後確實洗手。
- (2) 每日給予鼻胃管護理並更換乾淨之固定膠布。
- (3) 每 3 小時以空針反抽鼻胃管減壓，並觀察胃內容物與消化液之性狀。
- (4) 依醫囑測量體溫，監測生命徵象，觀察敗血症症狀。
- (5) 每班檢視腹部有無腹脹情形，紀錄鼻胃管引流液之性質、量、色、味道，如有多量黏液或出血、惡臭和量太多時，需告知醫師。
- (6) 監測並追蹤實驗室檢查結果，依醫囑給予抗生素治療。
- (7) 每隔 7 天以無菌技術重新更換一條鼻胃管。

（八）衛教指導

1. 教導病童之母正確收集與保存母乳之方法：

- (1) 清潔雙手、準備好乾淨的儲奶容器，讓自己身體放鬆。

主題名稱	新生兒壞死性腸炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N03	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	4/7

- (2)使用電動擠奶器：擠奶器的罩杯內緣套住乳暈處，按住開關乳汁將慢慢流出。
- (3)徒手擠乳：將手掌握成 C 型，將乳房握住往上提，大拇指跟食指放在乳頭上、下的輸乳竇處（通常在乳暈外圍 2-3 公分），先同時往胸部內壁壓，此時乳頭會往外突出，然後利用此兩指規律的壓擠輸乳竇。
- (4)擠出的母乳應於容器外標示日期、擠乳時間，並盡速冷凍。
- (5)保存期限：室溫 6-8 小時，冷藏 3-5 天，冷凍 3-4 個月。
- (6)回溫母乳：
- A.冷藏－以 50 度溫水慢慢隔水回溫，不可直接加熱或微波。
- B.冷凍－預餵食的母乳先置於冷藏解凍，再以冷藏方式回溫母乳。

（九）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

- （一）莊佳霖、吳麗月、張惠晴(2020).照護一位早產兒合併腹裂畸型術後之護理經驗.領導護理，21(3)，60-74。
- （二）陳月枝、黃靜微、林元淑、張綠怡、蔡綠蓉、林美華...魏琦芳(2021).實用兒科護理學（9 版）.台北市：華杏。
- （三）曹麗燕、林杏純、王杏安(2020).中晚期早產兒的餵奶策略與生長比較.臺灣膳食營養學雜誌，12(2)，1-16。

主題名稱	新生兒壞死性腸炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N03	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	5/7

七、附件

(略)

主題名稱	新生兒壞死性腸炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N03	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定	97 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
101.08.31	2.1	醫護部改護理部	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.1	1.第三項第(三)及(五)目部份內容刪修 2.增修第六項參考文獻資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.2	將參考文獻出處呈現於內文中	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.3	1. 增修第三項第(一)目定義內容。 2. 更正第三項第(三)目部分錯別字。 3. 新增第六項參考文獻資料。	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.09.23	3.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第九日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.06	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.08.05	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.09.06	3.5	1. 修訂第三項第六、七目護理問題。 2. 更新第六項文獻參考資料。 3. 刪除內文參考文獻。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護

主題名稱	新生兒壞死性腸炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N03	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	7/7

			理長會議通過;111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.09.05	3.6	1. 修訂第三項第七目、第八目說明內容。 2. 更新第六項參考文獻資料。	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過; 112 年 08 月 09 日護理長會議通過;112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。
113.09.03	3.7	更新第六項參考文獻資料。	113 年 08 月 08 日照護標準組會議通過; 113 年 08 月 14 日護理長會議通過;113 年 09 月 03 日督導會議通過公布。
114.10.08	3.8	1.修訂第三項第七目說明內容。 2.更新第六項參考文獻資料。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過; 114 年 09 月 10 日護理長會議通過;114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。